

保险 II 行业

“联合健康”深度解析及对我国的借鉴意义

核心观

- **联合健康简介：**美国最大的健康保险和健康管理服务集团。(1) 美国医疗费用高速增长，管理式医疗 HMO 概念被提出之际的 1974 年，公司由医生和保健专家发起设立，并不断创新和并购扩大客户基数和业务范围，健康险覆盖美国 13.1% 的人口，业务遍布美国 50 个州和全球 130 个国家；(2) 业务结构趋于均衡，ROE 持续走高。公司业务为健康险 UnitedHealthcare 和健康管理服务 Optum，利润率较高的 Optum 收入占比由 06 年的 12.2% 提升至 20 年的 40.4%，推动 ROE 由 21.5% 提升至 25.02%，远高于同业的安森（17.2%）、哈门那（22.3%）、信诺（11.2%）。(3) ROE 的提升推动股价持续创新高。截至目前，公司股价 10 年接近翻 10 倍，静态 PB 估值高达 6.23X，远远高于同业。
- **联合健康发展背景：**商业保险为主的医疗体系、高昂的医疗成本催生管理式医疗发展。20 年美国公共/商业医疗保险覆盖 34.8%/66.5% 的人口，20 年人均医疗费用高达 1.16 万美元，“看病贵”是美国医疗体系的核心痛点，1973 年颁布《健康维护组织法案》，鼓励 HMO 发展。
- **健康险：收购+医疗服务，保费与盈利能力齐飞。**健康险包括：老年人及退休、社区和州救济业务、雇主及个人业务、全球业务，06-20 年保费收入 CAGR 为 8.2%。公司优势在于：(1) 丰富的医疗资源，20 年公司医疗网络包括 140 万家庭医生和 6500 家医疗机构，为客户提供更好的健康医疗管理；(2) 医疗成本低于同业，20 年医疗赔付率为 79.1%，低于哈门那（83.1%）、安森（84.6%）和信诺（79.4%），主因公司凭借 Optum 降低医疗成本；(3) 强大的客户资源，与美国退休协会签署排他协议，20 年公司来自于 CMS 的保费占比高达 36%。
- **健康管理服务：发展迅速。**Optum 是公司健康管理与服务子公司，主要分为 OptumHealth（健康管理业务）、OptumInsight（信息技术服务）、OptumRx（药品服务管理）三个板块，随着业务范围的扩大和技术对外的输出，Optum 贡献的收入比重由 2006 年的 12% 提升至 40%，并且投入产出比的提升，Optum 的营业利润率由 2010 年的 4.8% 提升至 2020 年的 7.4%，其中信息技术服务的营业利润率高于其他两个板块。
- **投资建议：**考虑到医疗体系的差异（美国以私立医院为主，医药分家；中国以公立医院为主，医药不分家）、医保体系的差异（美国以商业健康险为主，中国以基本医保为主）等综合差异，打造“中国版”的联合健康较难，但通过医疗和养老服务进行差异化竞争，信息技术的发展有望促进保险业务发展和降低成本，因此综合推荐医疗健康布局较早的中国平安（A/H）、中国太保（A/H）、友邦保险（H）。
- **风险提示。**健康管理不达标；利率超预期下行，房地产行业风险蔓延。

行业评级

买入

前次评级

买入

报告日期

2022-01-12

分析师：

刘洪



SAC 执证号：S0260520060001



0755-82564292



liuqi@gf.com.cn

分析师：

陈福



SAC 执证号：S0260517050001



SFC CE No. BOB667



0755-82535901

chenfu@gf.com.cn

请注意，刘洪并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。

相关研究：

保险 II 行业：夯实资本质量，	2022-01-04
引导行业回归本源	
保险 II 行业：“降费”支持国	2021-12-14
家战略，好于市场预期	
保险行业 2022 年投资策略：	2021-12-02
财险柳暗花明，寿险韬晦待	
时	

重点公司估值和财务分析表

股票简称	股票代码	货币	最新 收盘价	最近 报告日期	评级	合理价值 (元/股)	EPS(元)		PE(x)		PEV(x)		ROE(%)	
							2021E	2022E	2021E	2022E	2021E	2022E	2021E	2022E
中国平安	601318.SH	CNY	53.08	20211028	买入	79.7	6.28	9.36	8.45	5.67	0.67	0.58	12.81%	17.37%
新华保险	601336.SH	CNY	40.02	20211031	买入	61.8	5.87	7.40	6.82	5.41	0.45	0.40	14.87%	17.24%
中国太保	601601.SH	CNY	28.11	20210830	买入	43.51	2.83	3.74	9.93	7.52	0.52	0.44	12.75%	10.94%
中国人寿	601628.SH	CNY	30.01	20211031	买入	38.75	2.07	2.46	14.50	12.20	0.71	0.63	9.94%	9.62%
中国平安	02318.HK	HKD	54.25	20211028	买入	88.4	6.28	9.36	7.06	4.74	0.56	0.49	12.81%	17.37%
新华保险	01336.HK	HKD	20.75	20211031	买入	36.32	5.87	7.40	2.89	2.29	0.19	0.17	14.87%	17.24%
中国太保	02601.HK	HKD	22.30	20210830	买入	32.70	2.83	3.74	6.44	4.87	0.33	0.29	12.75%	10.94%
中国人寿	02628.HK	HKD	12.96	20211031	买入	17.71	2.07	2.46	5.12	4.31	0.25	0.22	9.94%	9.62%
友邦保险	01299.HK	HKD	82.40	20211114	买入	121.59	0.53	0.59	19.94	17.92	1.77	1.59	9.17%	9.46%
中国财险	02328.HK	HKD	6.74	20211029	买入	9.96	1.10	1.24	5.01	4.44	0.60	0.59	12.13%	13.18%

数据来源：Wind、广发证券发展研究中心

备注：表中估值指标按照最新收盘价计算，EPS 中仅友邦保险为美元，估值中仅中国财险为 PB，其余为 PEV

目录索引

一、公司简介：应运而生，保险与健康管理深度协同	6
（一）历史沿革：应运而生，创新提升竞争力、收购拓展业务边界	6
（二）业务结构趋于均衡，深度协同推动 ROE 持续走高	7
二、发展背景：高昂的医疗费用催生管理式医疗	11
（一）医疗体系：以商业医疗保险为主	11
（二）医疗费用的高涨，管理式医疗发展解决“看病贵”	12
三、健康险：核心优势显著，保费与盈利能力齐飞	13
（一）健康险：收购兼并叠加优质医疗服务，客户覆盖人数持续提升	13
（二）四大板块：老年人医疗保险业务渐成“顶梁柱”	15
（三）优势解析：丰富的医疗资源、稳定的客源叠加强大的控费能力	18
四、健康管理业务：依托健康险业务，发展迅速	19
（一）健康管理业务总览：贡献集团收入的比重持续提升	19
（二）三大板块分析：信息技术服务盈利能力最佳	21
（三）协同：健康险提供客户来源，健康管理赋能	23
五、投资建议：国情差异，难打造中国版“联合健康”	24
（一）医疗制度的显著差异	24
（二）借鉴之处：差异化竞争，解决居民医疗痛点	26
（三）投资建议	27
六、风险提示	27

图表索引

图 1: 健康险业务和健康管理服务相互补充、相互促进	8
图 2: 1990-2020 年公司营业收入 (百万美元)	9
图 3: 1990-2020 年公司净利润 (百万美元)	9
图 4: 公司营业收入的业务结构	9
图 5: 公司总资产规模持续增长	9
图 6: 健康险业务和健康管理服务营业利润率水平	10
图 7: 联合健康 ROE 持续走高, 且高于同业	10
图 8: 联合健康和同业公司的 PB 估值 (MRQ)	10
图 9: 美国医疗保险体系	11
图 10: 2020 年美国医疗保险覆盖 91.4% 人群 (%)	11
图 11: 美国卫生费用占 GDP 比重高	12
图 12: 美国人均医疗卫生支出水平高	12
图 13: 2018 年成熟国家卫生费用支出占 GDP 比重 (%)	12
图 14: 美国医疗费用来源结构	12
图 15: 美国管理式医疗的四种模式	13
图 16: 2020 年管理式医疗在各医疗保险中的渗透率	13
图 17: 保费收入维持高速增长态势 (百万美元)	14
图 18: 健康险营收年均复合增速 9% (百万美元)	14
图 19: 公司健康险业务营业收入结构	15
图 20: 公司健康险覆盖人群占比持续提升 (千人)	15
图 21: Medicare&Retirement 营业收入 (百万美元)	16
图 22: Medicare&Retirement 营业收入占比	16
图 23: 雇主及个人业务营业收入 (百万美元)	17
图 24: 雇主及个人业务营业收入占健康险的比重	17
图 25: 公司医疗网络覆盖的医院及其他机构	18
图 26: 公司医疗网络覆盖的医生及其他医疗人员	18
图 27: 联合健康医疗赔付率逐渐走低	19
图 28: 2020 年同业医疗赔付率的比较	19
图 29: 公司营业收入中来自于 CMS 的保费占比	19
图 30: 健康管理业务营业收入及占比 (百万美元)	20
图 31: 健康管理业务结构	20
图 32: 健康管理业务营业利润率	21
图 33: 健康管理板块各业务条线营业利润率	21
图 34: OptumHealth 营业收入规模及增速 (百万美元)	21
图 35: OptumHealth 占 Optum 营业收入比重	21
图 36: 公司管理的药品支出规模在持续增长	23
图 37: OptumRx 的营业收入和占比 (百万美元)	23
图 38: 健康险业务和健康管理服务相互促进、互为补充	24
图 39: 美国以私立医院为主 (截至 2019 年末)	25
图 40: 中国以公立医院为主	25
图 41: 三级医院的病床使用率高于医院整体水平 (%)	25

图 42: 公立医院和民营医院医师日均诊疗人次 (人)	25
图 43: 美国医疗费用来源结构	26
图 44: 我国医疗费用来源结构	26
表 1: 联合健康历史发展沿革	7
表 2: 联合健康股价明显跑赢同业和市场 (截至 2022 年 1 月 11 日)	10
表 3: 健康险四大业务简介	14
表 4: 美国老年医疗保险制度	15
表 5: 联合健康雇主及个人业务的主要产品	17
表 6: OptumInsight 客户的主要服务内容	22

一、公司简介：应运而生，保险与健康管理深度协同

（一）历史沿革：应运而生，创新提升竞争力、收购拓展业务边界

联合健康是美国最大的健康保险及健康管理服务集团，主要经营健康保险和健康管理服务。集团成立于1974年，由医生和医疗保健专家发起设立，最初主要经营健康险，之后逐渐拓展至健康管理服务和信息技术服务，且经营地区由美国拓展至全球。公司发展历史可分为三个阶段：

一是发起设立阶段。20世纪70年代由医疗政策专家Paul Ellwood和创业家Richard Burke创立，其中Ellwood是美国管理式医疗HMO之父，在1965年美国正式实施Medicare和Medicaid等社会医疗保险后，美国医疗费用开启高速增长阶段，卫生费用占GDP比重由1965年的5.6%提升至1975年的7.9%，在卫生费用大幅增长的背景下，Ellwood在1970年首次提出管理式医疗HMO的概念；而Burke最开始受Ellwood的聘请帮助管理HMO，经过了多年的HMO的管理，在1974年建立了联合健康的前身“Charter Med Incorporate”，1977年正式成立联合健康公司，成为其前身的母公司。联合健康诞生营运而生，出生于美国管理式医疗HMO开启的年代，并且由医疗政策专家和HMO管理专家联合建立，诞生之初便蕴含了医疗健康管理的基因，为后续公司的产品创新和收购兼并奠定了基本方向。

二是产品创新和信息技术管理阶段。20世纪70至90年代，集团进行了一系列创新，包括老年医疗产品、疗养院个人护理计划、药品福利管理、移植网络、AI智能系统等。公司通过不断的产品创新和信息技术管理等方式，不断的拓展业务的范围，并且提升客户的健康管理体验，增强粘性，也为公司与政府主体建立良好的合作奠定基础。

三是收购兼并及扩张阶段。20世纪90年代至今，集团通过收购兼并不断拓展业务范围和能力，包括收购Amecichoice、Pacificare、Sierra、Amil等，拓展Medicaid、Medicare Advantage、巴西等业务，并且在健康管理业务方面，通过不断的收购医疗技术相关的子公司来迅速加强公司的技术实力，与公司积累的信息技术实力不断整合。

经过近半个世纪的发展后，联合健康成为美国最大的健康保险及健康管理服务集团，截至2020年末，集团拥有33万雇员，其中有12.5万医疗专业人士，健康险业务服务用户4,844万，占美国人口比例13.1%，业务覆盖美国50个州和全球130个国家，总资产1973亿美元，净资产705亿美元。2021年《财富》杂志发布世界500强排行榜，联合健康集团力压伯克希尔哈撒韦，首次进入全球前十，排名第八。

表1: 联合健康历史发展沿革

时间	事件
1974	公司前身 Charter Med Incorporated 成立
1977	医疗政策专家 Paul Ellwood 和创业家 Richard Burke 创立 United HealthCare Corporation，并收购 Charter Med Incorporated
1979	推出第一个针对老年人的网络化健康方案，并参与了医疗保险提供私人市场替代饭干的最早试验
1984	UnitedHealth 纽交所上市
1985	收购美国中部人寿保险公司（LOMA）
1987	推出 EverCare 项目，旨在帮助协调疗养院个人护理计划
1988	创建现代药房福利管理业务（PBM），通过子公司将福利设计与零售药房网络和邮件服务联系起来
1989	引入移植网络，改善患者护理，降低移植成本
1995	收购 MetraHealth Companies, Inc. 标的是旅行者保险和大都会的团体健康险业务
1996	推出 AdjudiPro 系统，可自动处理投诉审查流程
1997	AARP（美国退休协会）指定公司为其成员提供健康保险服务
1998	更名为 UnitedHealth Group，并创立五大业务线：UnitedHealthcare、Uniprise、Ovations、Specialized Care Services 和 Ingenix 推出 Clinical Profiles 项目，基于数据平台进行诊疗结果的比较
1999	收购 Dental Benefit Providers，扩大产品组合到牙科护理福利的管理服务 推出 Care Coordination 项目，提高医疗服务的便捷和舒适性
2000	推出 myuhc.com，使个人客户能够订购身份证、检查索赔状态并在线访问相关健康信息
2002	收购 AmeriChoice，AmeriChoice 是为各州 Medicaid 计划提供医疗服务，进一步拓展公司业务
2005	收购 PacifiCare，运营美国最大的 Medicare Advantage 计划之一，为雇主团体、个人和医疗保险受益人提供 HMO 和其他健康保险产品
2007	收购 Sierra Health Services，其附属机构是内华达州最大的专业医疗集团，强化公司在美国西南地区的地位 业务板块调整为 Health Care Services、OptumHealth、Ingenix、Prescription Solutions Ingenix 收购 AIM 和 CareMedic，其中 AIM 是美国领先的医疗保险支付方案提供商，而 CareMedic 主要是医院收入管理业务
2009	OptumHealth 推出 eSync 平台，它通过结合处方药使用情况、近期医疗信息和自我报告信息等提供患者病史的整体视图 与思科建立合作伙伴关系，以建立第一个全国远程医疗网络，当无法亲自就诊时，该网络将使患者能够接触到医生和专家
2010	OptumInsight 收购 Picis, Executive Health Resources 和 Axolotl，其中 Picis 是医院急诊室健康信息提供商
2011	OptumHealth 收购 Logistics Health，是为美国军队/退伍军人和商业公司提供职业健康、医疗和牙科服务、治疗和免疫计划以及残疾检查 成立 UnitedHealthcare 和 Optum 业务平台，分别运营健康险和健康管理服务
2012	收购 Amil，是巴西最大的医疗保健公司，为超过 500 万人提供健康和牙科福利、医院和临床服务 Prescription Solutions 更名为 Optum RX
2013	推出 Optum360，简化患者的成本透明度，推动医院、护理提供商和付款人的管理现代化
2015	OptumRx 收购 Catamaran Corporation，提供互联、个性化的药房护理体验
2016	OptumRx 与 CVS Pharmacy 合作，为雇主提供欣的药房网络解决方案
2017	与 AARP 续签独家合作关系
2018	与其他两家健康险公司 Humana 和 Multiplan，医疗信息技术供应商 Quest Diagnostics 应用区块链技术合作试点项目

数据来源：公司官网，广发证券发展研究中心

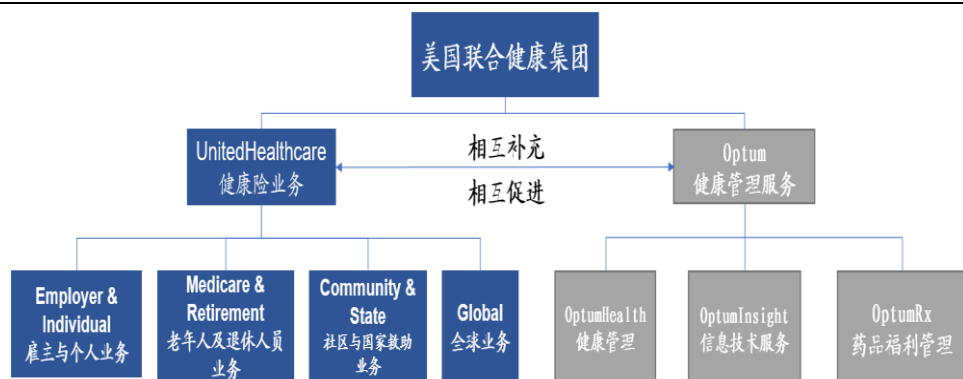
（二）业务结构趋于均衡，深度协同推动 ROE 持续走高

集团以健康险业务为基础，后催生健康管理服务业务，打造业务闭环。健康险业务根据不同的服务对象分为雇主与个人业务、老年人及退休人员业务、社区与国家救助业务和全球业务。健康管理服务业务利用信息计算为医疗产业参与者提供多样化

的服务，以提高消费者体验、降低医疗服务提供成本、提高医疗机构运行效率，具体业务包括健康管理服务（OptumHealth）、药品福利管理（OptumRx）和信息技术服务业务（OptumInsight）。

在公司的发展过程中，健康保险、健康服务和技术是相辅相成的，深度协同。一方面，集团在健康险业务的长期积累，为健康管理服务业务提供强大的客户基础，并加大公司与医疗机构、药店等合作时的话语权，进一步提高健康管理服务业务的盈利能力。另一方面，健康管理服务业务进一步完善集团业务板块、改善消费者体验并加大用户粘性、降低健康险业务成本、提高集团的盈利能力，促进更高质量地发展。医疗服务网络具有规模效应，不断强化集团在竞争中的优势地位。集团可利用健康险客户的规模优势，既加大议价权，降低医疗费用成本，又吸引更多的医疗服务提供者加入集团的关系网络，壮大医疗服务网。集团健康险客户可以以更低的费用享受更高质量的服务，有利于吸引更多健康险客户。

图1：健康险业务和健康管理服务相互补充、相互促进

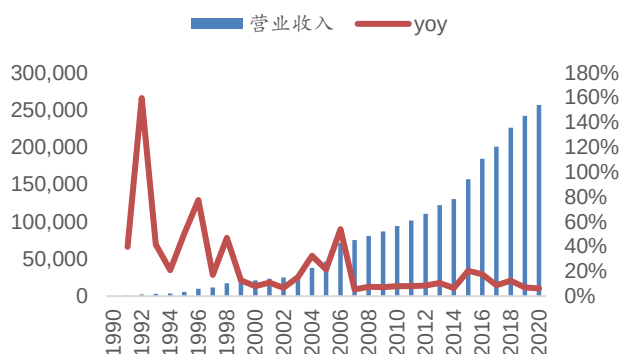


数据来源：公司年报，广发证券发展研究中心

在两个板块业务的协同促进下，公司的业绩维持稳定增长的态势。2020年公司营业收入为2571亿美元，同比6.2%，1990-2020年复合增速为22.3%，净利润规模为154亿美元，同比增长11.3%，1990-2020年复合增速22.6%，保持较高的增长。

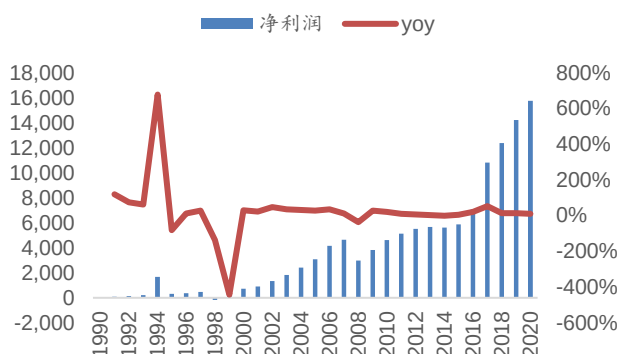
从业务结构来看，随着公司逐步将重心慢慢转移至健康管理服务业务，健康管理服务贡献的收入占比逐步提升，由2006年的93.8亿美元增长至2020年的1363亿美元，年均复合增速为21.1%，远高于健康险业务的8.1%，因此健康管理业务的收入占比由2006年的12.2%提升至2020年的40.4%，而健康险业务收入贡献的占比由2006年的87.8%下降至如今的59.6%，公司业务结构日趋均衡。

图2: 1990-2020年公司营业收入 (百万美元)



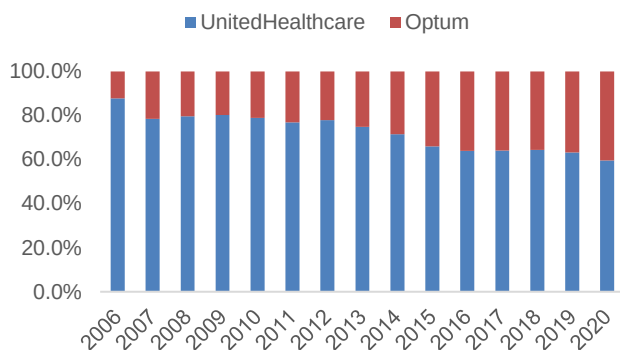
数据来源: 公司年报, 广发证券发展研究中心

图3: 1990-2020年公司净利润 (百万美元)



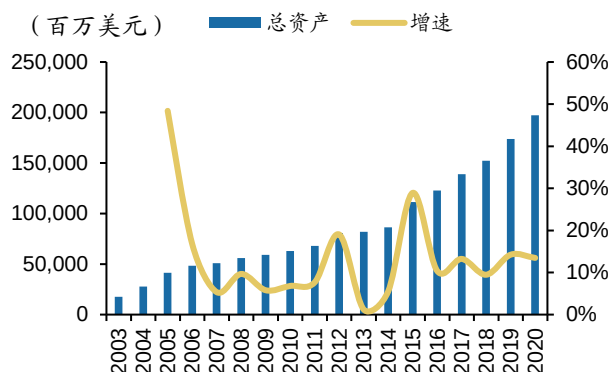
数据来源: 公司年报, 广发证券发展研究中心

图4: 公司营业收入的业务结构



数据来源: 公司年度报告, 广发证券发展研究中心

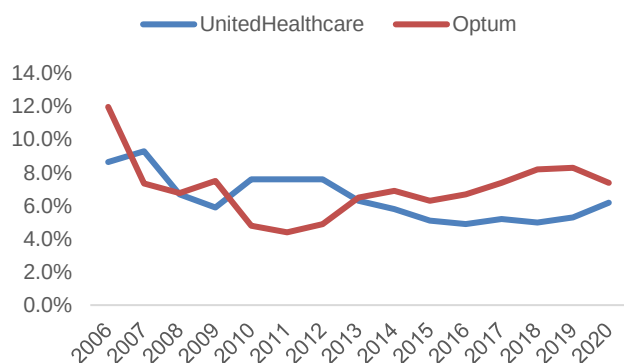
图5: 公司总资产规模持续增长



数据来源: 公司年度报告, 广发证券发展研究中心

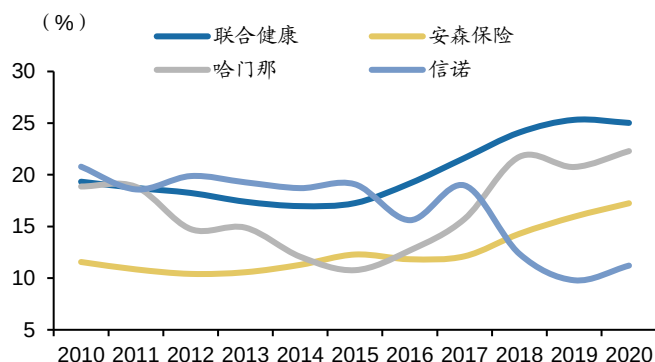
近年来集团ROE持续走高，并且远远领先于同业，原因是集团业务结构进一步均衡，高利润率的健康管理服务业务占比不断提高。ROE纵向比较看，2020年公司ROE水平为25.02%，较2006年的21.5%有明显提升，主要是公司业务结构进一步均衡，营业利润率相对较高的健康管理服务占比逐步提升，由2006年的12.2%提升至目前的40.4%，并且健康管理服务的营业利润率在2010年开始持续提升；ROE横向比较来看，2020年公司ROE水平高于同业的安森保险（17.2%）、哈门那（22.3%）、信诺（11.2%），预计主要是公司规模较大，降低部分固定成本，另外公司凭借丰富的数据积累和强大的数据分析能力，医疗赔付率长期低于主要同业竞争对手，提升公司的营业利润率水平。

图6：健康险业务和健康管理服务营业利润率水平



数据来源：彭博，广发证券发展研究中心

图7：联合健康 ROE 持续走高，且高于同业



数据来源：彭博，广发证券发展研究中心

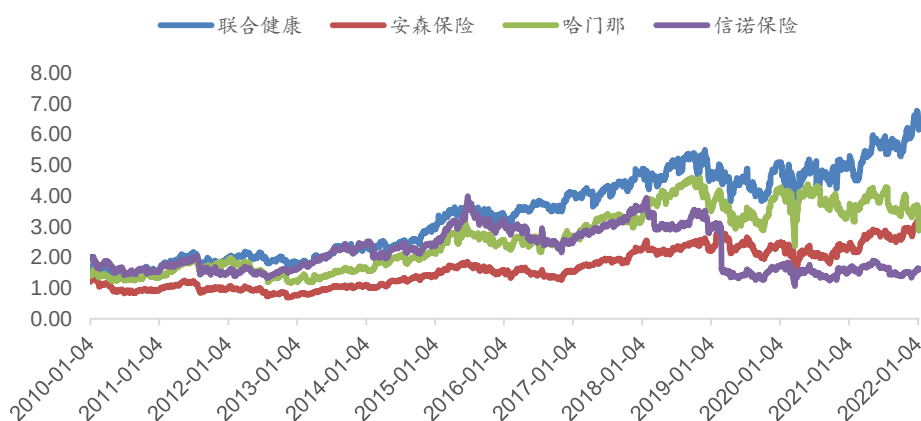
盈利能力保持稳定增长，持续提升的ROE推动联合健康股价的表现明显优于同业和市场。截至2022年1月11日，联合健康10年接近翻了10倍，同期的安森保险、哈门那、信诺和标普500指数涨幅分别为603.6%、342.5%、421.8%、261.5%，ROE的走高也持续推动联合健康的PB估值，截至目前，联合健康PB估值为6.23X，远高于同业，且较2010年初的1.6X大幅提升。

表2：联合健康股价明显跑赢同业和市场（截至2022年1月11日）

	联合健康	安森保险	哈门那	信诺保险	标普 500 指数	标普医疗指数
1 年涨幅	30.7%	30.8%	-10.6%	8.2%	22.9%	15.1%
2 年涨幅	62.9%	46.6%	7.1%	12.9%	42.6%	32.2%
5 年涨幅	209.7%	219.7%	96.0%	66.9%	105.3%	93.6%
10 年涨幅	924.9%	603.6%	342.5%	421.8%	261.5%	285.5%

数据来源：wind，广发证券发展研究中心

图8：联合健康和同业公司的PB估值（MRQ）



数据来源：wind，广发证券发展研究中心

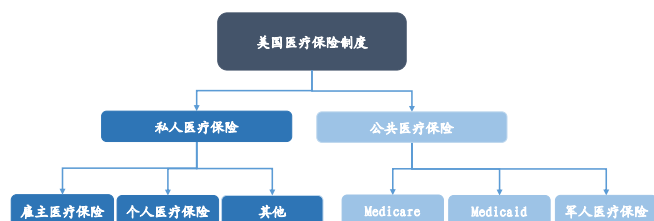
二、发展背景：高昂的医疗费用催生管理式医疗

（一）医疗体系：以商业医疗保险为主

美国是典型的商业医疗保险体系，分为公共医疗保险和商业医疗保险。公共医疗保险主要计划有老年人医疗照顾计划（Medicare）、为低收入人群提供的医疗救助计划（Medicaid）、儿童健康保险项目（CHIP）和军人医疗保险等。**Medicare**为65岁以上老年人口、残疾人和终末期肾病患者提供医疗服务，包括医院保险服务（A计划）、医疗保险服务（B计划）、医疗优势计划（C计划）和处方药计划（D计划）等；**Medicaid**针对低收入群体的医疗健康保障项目，主要针对低收入的成年人、儿童、孕妇、65岁或以上人士、残疾人士等提供免费或者低成本的医疗福利，由美国联邦政府和各州政府共同资助。

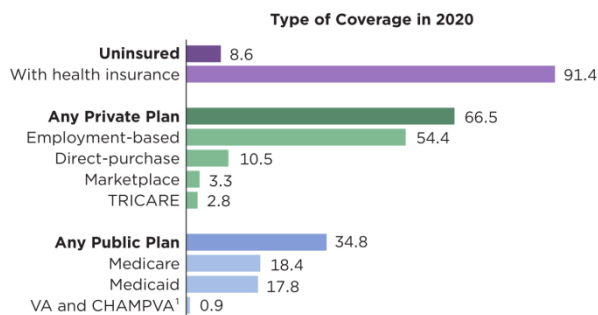
商业医疗保险主要是雇主为员工购买为主，个人购买为少数。除了传统的商业保险市场外，美国商业保险公司还可以进入公共医疗保险市场，通过可与政府合作，参与**Medicare**和**Medicaid**等公共医疗保险计划，以满足民众更大的医疗保障需求和减轻政府负担。商业保险公司提供**Medicare**优势计划，可涵盖Part A（住院和护理费用）、Part B（门诊费用）和Part D（特殊药费用）。截至2020年，医疗保险覆盖美国91.4%的人群，其中2.17亿人拥有商业医疗保险，占人口比重高达66.5%，**Medicare**占比18.4%，**Medicaid**占比17.8%。（数据来源：美国人口统计局）

图9：美国医疗保险体系



数据来源：美国人口统计局，广发证券发展研究中心

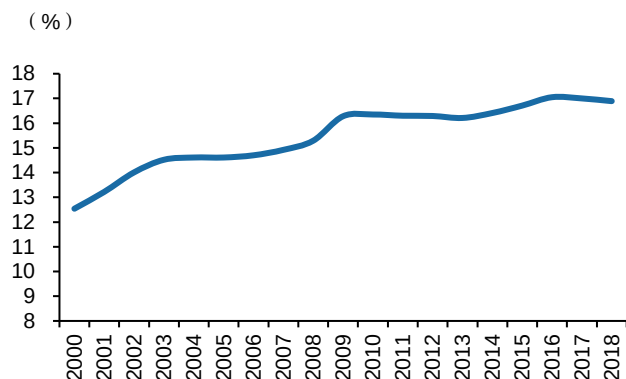
图10：2020年美国医疗保险覆盖91.4%人群（%）



数据来源：美国人口统计局，广发证券发展研究中心

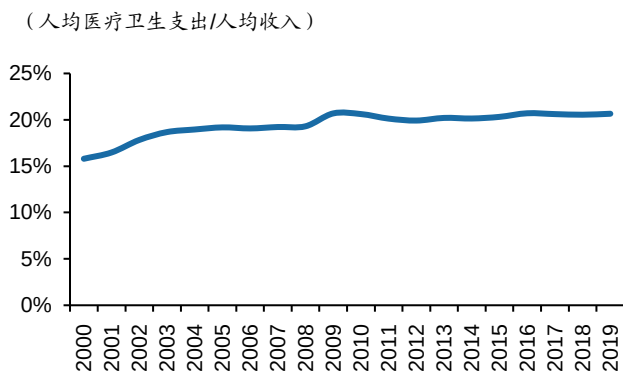
美国是典型的市场经济国家，新型和昂贵的医疗技术的应用、高昂的医师费用、人口的老齡化均在推动美国医疗卫生费用的快速上涨。2020年美国卫生费用3.8万亿美元，自1960年以来复合增速高达8.7%，人均卫生费用为11582美元，1960年以来CAGR为7.7%，占人均收入的比重达到20.7%。59年来保持较高的增长，增速超过GDP增速，因此卫生费用占GDP的比重持续提升，2020年达到17.7%，远高于全球水平，高于其他发达国家水平。在卫生费用持续上涨的背景下，若无医疗险的覆盖，个人较难支付大额的医疗费用开支，因此从美国的情况来看，“看病贵”才是居民的核心痛点。（数据来源：WHO和美国CMS）

图11: 美国卫生费用占GDP比重高



数据来源: WHO, 广发证券发展研究中心

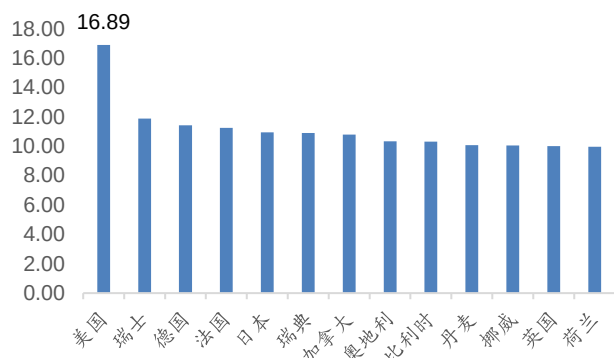
图12: 美国人均医疗卫生支出水平高



数据来源: CMS, FRED, 广发证券发展研究中心

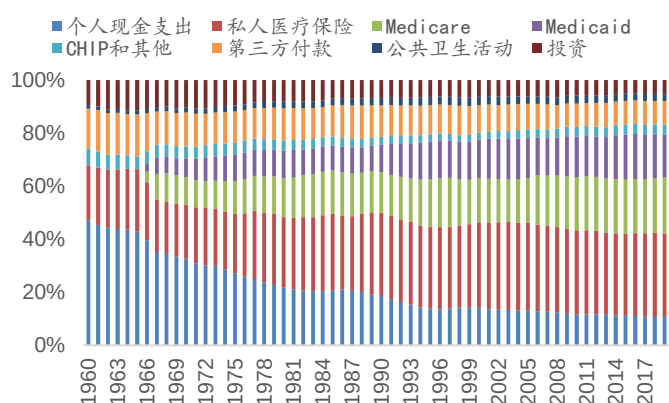
从医疗费用的来源看, 医疗保险是最主要的支付方, 2019年贡献73%的医疗费用来源, 其中私人医疗保险占比31%, 较1960年的20.8%提高10个百分点; 而公共医疗保险贡献42% (Medicare 21%、Medicaid联邦资金10%、Medicaid州政府6%、其他公共医疗保险4%); 而个人现金支出占比仅为11%, 相较于1960年的47.1%大幅下滑。(数据来源: 美国CMS)

图13: 2018年成熟国家卫生费用支出占GDP比重 (%)



数据来源: WHO, 广发证券发展研究中心

图14: 美国医疗费用来源结构



数据来源: CMS, 广发证券发展研究中心

(二) 医疗费用的高涨, 管理式医疗发展解决“看病贵”

随着社会保险和商业医疗保险的覆盖持续提升、先进医疗技术的应用、人口老龄化的发展, 美国医疗费用大幅提升, 催生了管理式医疗的发展。美国健康险以管理式医疗模式为主, 管理式医疗是一种通过保险机构与医疗服务提供者达成协议向投保人提供医疗服务的模式。与传统的医疗保险不同, 在管理式医疗保险中, 所有医疗网络成员都部分承担医疗费用风险, 能更好地避免过度用药、过度治疗等问题, 提高医疗费用的利用效率、降低保险公司的费用成本。

在1965年美国推出Medicare和Medicaid后, 民众的过度医疗导致政府医疗费用支出的快速增长, 1973年为了遏制日益高涨的医疗费用, 《健康维护组织法案》正式

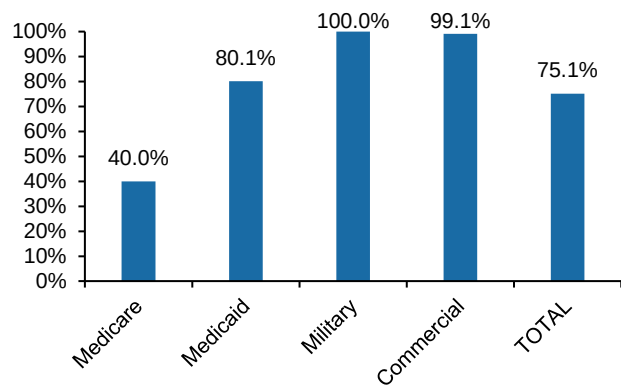
问世，鼓励健康维护组织（HMO）的发展。截至到目前，美国的管理式医疗主要分为HMO、PPO、EPO、POS四种模式，主要差别在于会员能否去网络外就医。管理式医疗能够有效的将医疗服务提供商、医疗服务需求者和医疗服务费用支付方有效的结合，有效的配置医疗服务和降低医疗费用，截至2020年，管理式医疗渗透率达到75%，其中Medicare和Medicaid的渗透率为40%、80.1%。（数据来源：MCOL）

图15：美国管理式医疗的四种模式

HMO	PPO	EPO	POS
- 健康维护组织 - 是一种保险计划，由当地的医生和医院等发起设立，一般不包含网络以外的医疗服务。	- 优选医疗机构 - 是由医生和医院组成的网络，可以以较低的价格获取网络内的医疗服务，且能够额外服务获得网络外的医疗服务	- 指定医疗服务机构 - 只允许成员在网络内的提供商服务，不要求成员指定家庭医生	- 定点服务组织 - 要求成员必须选择一个初级医生，需要初级医生转诊才可去看专科医生，在特殊情况下允许成员到网络外就医

数据来源：CMS，广发证券发展研究中心

图16：2020年管理式医疗在各医疗保险中的渗透率



数据来源：mcol，广发证券发展研究中心

管理式医疗模式需要高度专业化的运营，保险公司需要对接医疗机构、医生及药品提供商，并对医疗服务的内容高度了解，要想充分发挥管理式医疗的优势，保险公司需要具备专业的医疗服务知识、强大的医疗服务关系网络以及坚实的客户基础。在管理式医疗模式下，有较好客户基础或医疗服务网络的商业保险公司，能吸引更多稳定、高质量的客户和更多的医疗服务机构，使得服务网络不断扩大，让客户能以更低的成本获得更高质量的医疗服务。联合健康在早期便注重建立医疗服务网络，现已形成了强大的医疗服务网络。截至2020年末，联合健康与140万医师和健康服务专家，超6,500家医疗服务机构建立合作关系。

三、健康险：核心优势显著，保费与盈利能力齐飞

（一）健康险：收购兼并叠加优质医疗服务，客户覆盖人数持续提升

公司健康险业务主要是为客户提供全方位的健康福利计划，为客户创造更好的医疗体验，并帮助客户控制不断上涨的医疗成本，也是公司客户的入口。健康险业务根据服务的客户对象划分为包含四部分：老年人及退休业务、雇主及个人业务、社区和州救助业务、全球业务，其中老年人及退休业务作为传统政府提供的Medicare计划的补充，满足老年人更多更个性化的需求；社区和州救助业务主要参与州立的Medicaid项目和儿童健康保险项目（CHIP），为低收入群体提供保障；雇主及个人业务则是为雇主和个人提供健康保险计划；全球业务主要是为其他国家提供健康保险业务，业务遍布150多个国家，集中于巴西、智利、哥伦比亚和秘鲁，主要提

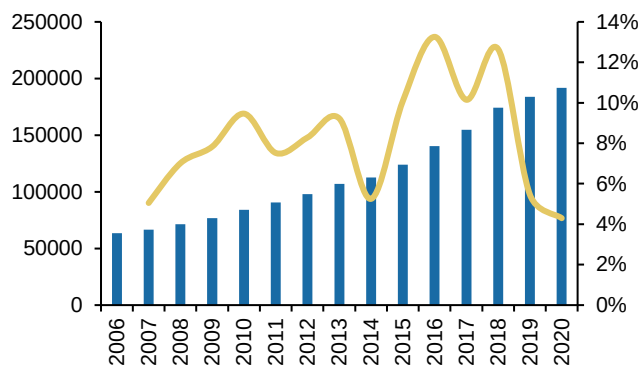
供医疗和牙医服务。

表3: 健康险四大业务简介

健康险业务	老年人及退休业务	针对老年人预防性医疗、严重疾病医疗、慢性病医疗及其他老年人常见疾病的医疗需求提供专业服务。 产品: Medicare 优势计划、Medicare 处方药计划和 Medicare 补充计划。
	社区和州救助业务	为社区和州提供医疗救助计划 Medicaid 和儿童健康保险项目服务等, 覆盖 31 个州、660 万人口。
	雇主及个人业务	服务大型全国性雇主、公共部门雇主、中型企业雇主、小型企业和个人消费者, 服务超 2,620 万人。产品: (1) 为大型雇主提供的自筹资金计划, 赚取固定服务费; (2) 为小型雇主和个人提供的基于风险设计的产品。
	全球业务	布局 150 多个国家, 主要在巴西、智利、哥伦比亚和秘鲁。为 760 万人提供医疗和牙医服务。在巴西通过 Amil 服务 340 万消费者, 在智利、哥伦比亚和秘鲁通过 Empresas Banmédica 服务 200 多万消费者。

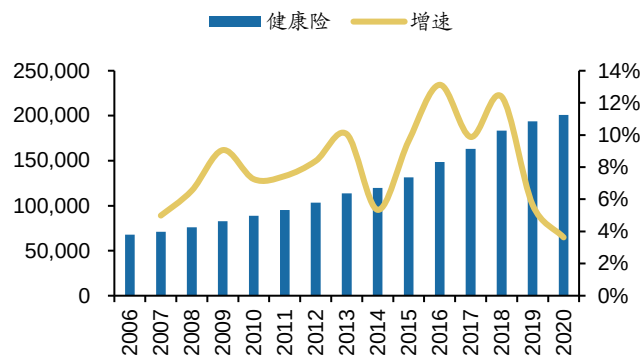
数据来源: 联合健康 2020 年年报, 广发证券发展研究中心

图17: 保费收入维持高速增长态势 (百万美元)



数据来源: 公司年度报告, 广发证券发展研究中心

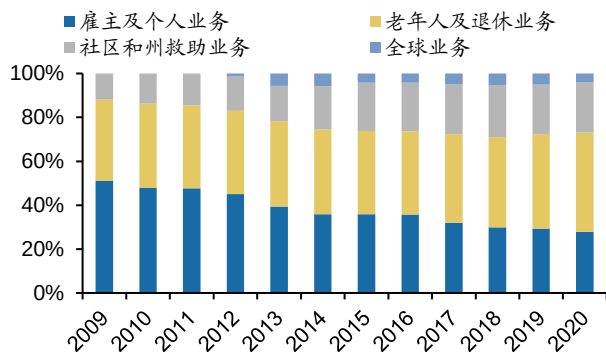
图18: 健康险营收年均复合增速 9% (百万美元)



数据来源: 公司年度报告, 广发证券发展研究中心

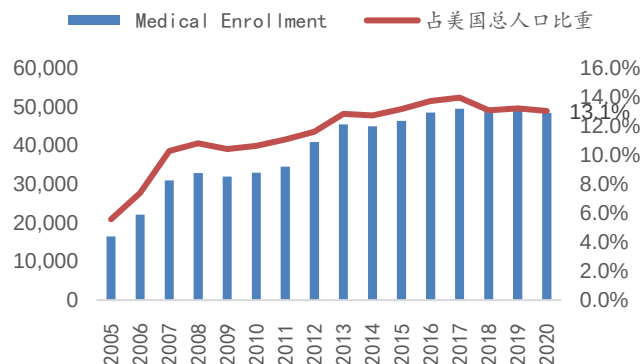
公司健康险业务凭借收购拓展业务条线, 并依托强大的本地医疗资源、丰富的产品线、集团优质的医疗服务, 健康险业务规模维持高速增长态势。健康险保费规模由2006年的634亿美元增加至2020年的1916.8亿美元, CAGR为8.2%, 营业收入从678.2亿美元增长至2008.8亿美元, CAGR为8.1%, 其中老年人退休业务、雇主和个人业务、医疗救助业务、全球业务占比分别为45.2%、27.8%、23.1%、3.9%, 较2010年来看, 老年人退休业务提升8pct, 而雇主和个人业务占比下降20pct, 救助业务和全球业务分别提升8.4pct、3.8pct。截至2020年, 联合健康险业务的客户数达到4843.5万人, 其中美国本土客户4301万, 占美国总人口比重为13.1%, 而2005年这一比例仅为5.6%。

图19：公司健康险业务营业收入结构



数据来源：公司年度报告，广发证券发展研究中心

图20：公司健康险覆盖人群占比持续提升（千人）



数据来源：公司年度报告，广发证券发展研究中心

（二）四大板块：老年人医疗保险业务渐成“顶梁柱”

1. 老年人医疗险及退休业务

老年人医疗保险和退休业务主要是为50岁及以上的个人提供健康服务，产品销售对接老年人医疗保险Medicare和美国退休人员协会（AARP）。美国社会医疗保险中的老年医疗保险计划Medicare成立于1965年，由联邦政府管理，各州实施统一政策，由住院保险（A）、医疗保险（B）、医疗优势计划（C）和处方药计划（D），其中A类为强制性计划，且不需要额外支付保费，但B、C、D类计划属于自愿类性质，需要额外缴纳保险费。1982年《税收公平和财政责任法案》授权CMS购买商业保险公司的医疗保险服务，开启商业保险公司参与社会医疗保险的市场，目前Medicare的B、C、D计划方面均可引入商业医疗保险公司进行承保。

表4：美国老年医疗保险制度

Medicare（老年医疗保险制度）

对象

1. 65 岁以上老人、残疾人士、终末期肾病患者
2. 美国公民或者永久居民，缴纳 10 年或者 40 个季度以上的医疗保险税

保障内容

Medicare A（医院保险）：报销医院的住院护理，包括急诊和专业护理机构。缴纳足额税率（2.9%）的人 65 岁以后自动加入 Medicare A。每年的责任负担额为 1484 美元，则报销 60 日内的全额住院费用、61-90 天为每日超过自负额 371 美元以外的住院费用报销；91 天以后的自负额为每日 742 美元。

Medicare B（医疗保险）：医生的服务和门诊护理。自由加入，每年缴纳 203 美元的责任负担额，则报销 80% 医生服务和门诊护理费用

Medicare C（医疗优惠计划）：自由加入，费用根据不用的计划而不同

Medicare D（处方药计划）：需要加入 Medicare 药物承保的计划，需要另外支付保费。自由加入，不同的计划不同的保费，且若收入高于计划上报的则要另外增加保费。

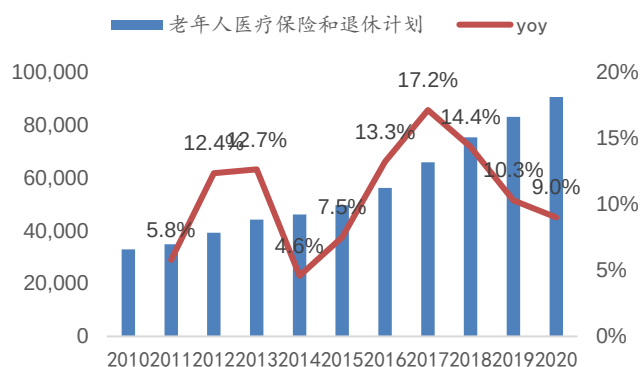
数据来源：CMS，广发证券发展研究中心

联合健康凭借早期的健康管理基因、广泛的销售能力、遍布全美的医疗资源等优势，老年人医疗保险和退休业务营业收入维持稳定增长，占公司健康险业务板块第一。公司最初便是从老年人医疗保险业务入手，1979年推出第一个针对老年人的网

络化医疗服务，市场替代Medicare，1987年推出EverCare计划，为老年人提供护理服务，1998年公司与AARP签订了为期10年的合同，成为AARP指定的健康保险服务供应商，彻底为公司的业务打开市场空间。截至2020年，公司老年人医疗保险和退休业务的营业收入为907.6亿美元，较2010年复合增速为11%，占健康险业务营业收入的比重由37.2%提升至45.2%。

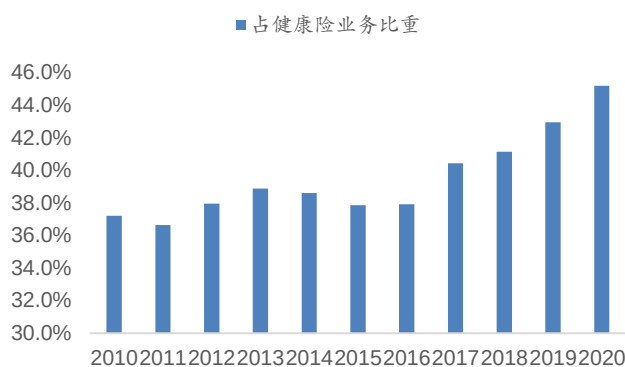
展望未来，随着美国人口结构的变化，尤其是65岁以上人口的占比持续提升，Medicare覆盖的对象持续提升，公司的老年人医疗保险和退休业务的保费及营业收入有望维持持续增长的态势。

图21: Medicare&Retirement营业收入（百万美元）



数据来源：公司年度报告，广发证券发展研究中心

图22: Medicare&Retirement 营业收入占比



数据来源：公司年度报告，广发证券发展研究中心

2. 雇主及个人业务

公司雇主及个人业务主要是向大型雇主、公共部门雇主、中型雇主、小型企业和个人消费者提供全面的健康险产品和服务，主要的产品包括传统产品、消费者参与产品、临床和药物产品、特别产品等四大类。美国社会医疗保险覆盖的范围相对有限，2020年占比仅34.8%，而医疗成本相对较高，因此商业医疗保险愈显发达，商业医疗保险大部分被当作企业福利措施之而实施，几乎所有的大企业都为雇员购买商业医疗保险，截至2020年商业医疗保险覆盖美国66.5%的人口。联合健康的雇主及个人业务包括两类，一方面是团体业务，即部分大企业承担员工的医疗风险，而联合健康为其协调医疗服务体工商等网络，进而收取手续费；另一类是基于风险的保险产品，即根据不同的人群、年龄的地区等确定其保费，由联合健康承担投保人的医疗健康风险。

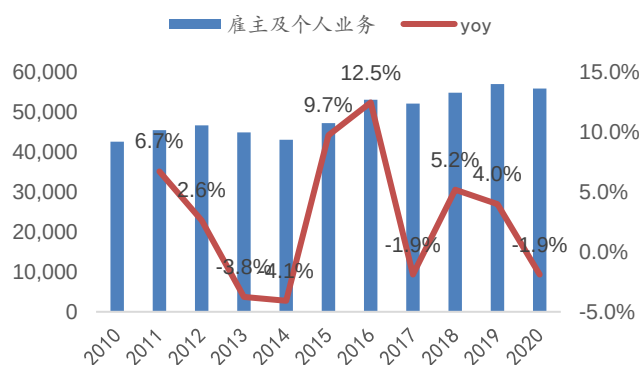
联合健康的雇主及个人业务发展同样离不开其外延并购，在1995年，联合健康通过收购旅行者保险和大都会的团险业务整合而成的Mentrahealth，而后者拥有超过1000万的客户，因此此次收购又一次拓展了公司业务覆盖范围。目前由于商业健康险的渗透率相对较高，且雇主和个人业务的竞争相对白热化，公司雇主和个人业务的营业收入保持相对稳定，2020年营业收入558.7亿美元，2010-2020年复合增速为2.8%，占健康险业务的营业收入比重由2010年的48%下降至27.8%。

表5: 联合健康雇主及个人业务的主要产品

传统保险产品	消费者参与产品	临床和药物产品	特别产品
全方位的医疗保险计划和医疗服务网络选择, 并提供一系列保障服务, 包括预防保健、直接咨询专家和灾难性保护等	将保险产品计划与投保人财务账户结合, 以增加个人对其健康和医疗服务责任, 包括高免赔额的保险产品, 并配以健康报销账户 (HRA)、健康储蓄账户 (HSA) 和消费者参与服务	提供完整的临床和药房护理服务产品, 通过提高护理质量、吸引消费者和提供节省成本的选择来补充其服务产品	牙科、视力、听力和其他专业福利, 包括事故保护、重大疾病、残疾和医院赔偿服务

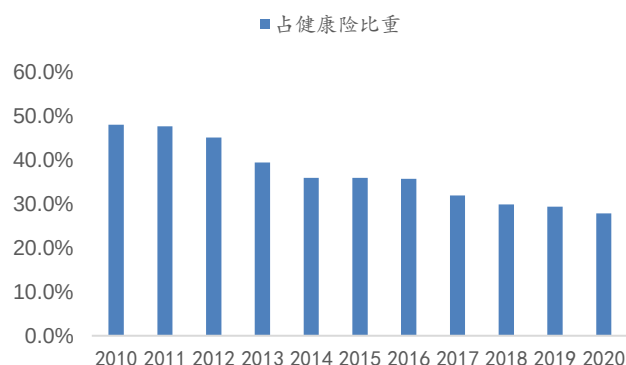
数据来源: 公司年度报告, 广发证券发展研究中心

图23: 雇主及个人业务营业收入 (百万美元)



数据来源: 公司年度报告, 广发证券发展研究中心

图24: 雇主及个人业务营业收入占健康险的比重



数据来源: 公司年度报告, 广发证券发展研究中心

3.社区和州立医疗救助业务

公司社区和州立医疗救助业务主要是为各州实施的Medicaid计划提供医疗服务。Medicaid计划是为低收入成年人、儿童、孕妇、65岁或以上人士、残疾人士等提供免费或者低成本的医疗福利, 由美国联邦政府和各州政府共同资助, 医疗救助采用联邦和州两级供款模式。而低收入群、儿童、孕妇等人群主要聚集于医疗服务不足的地区, 因此公司凭借其多年的医疗服务网络的经验、强大的监管战略合作关系等能力, 协调医疗服务提供商的资源, 为Medicaid的成员提供医疗服务。

2002年公司收购AmeriChoice, 作为专业的社区和州立救助业务的平台, 截至2020年公司参与了31个州的Medicaid的服务, 覆盖660万客户, 创造营业收入464.9亿美元, 占健康险业务比重为23.1%, 较2010年的14.8%提升8.4个百分点。

4.全球业务

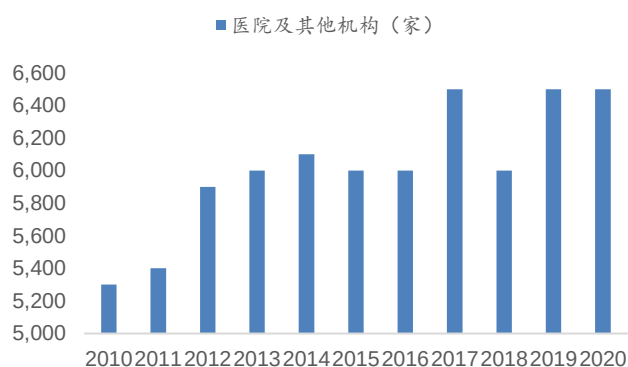
公司全球业务是为其他国家提供健康保险产品、护理服务等, 主要通过50家医院、200家诊所和手术中心等提供专项医疗服务。公司业务覆盖的国家包括巴西、智利、哥伦比亚、秘鲁等150个国家和地区。截至2020年, 公司全球业务营业收入为77.5亿元, 占健康险业务整体比重为3.9%。

（三）优势解析：丰富的医疗资源、稳定的客源叠加强大的控费能力

1. 强大的医疗资源网络

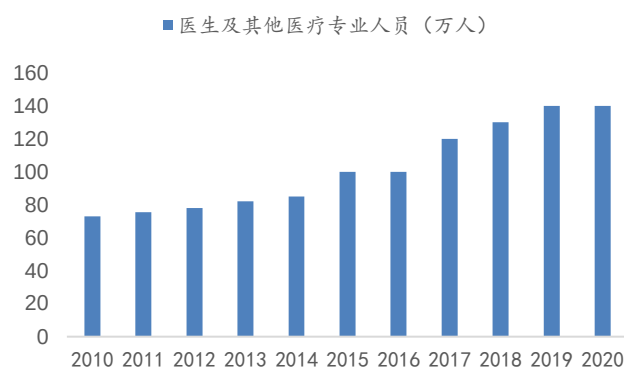
联合健康丰富的医疗资源和服务网络为健康险业务获得更多的客户，提升产品竞争力。一方面，公司创始人兼第一任CEO “Richard Burke” 受政策专家的邀请管理HMO，具备医疗资源的整合的能力，后续的几任CEO也均有医疗方面的背景，进一步带动联合健康获取更多的医疗资源；另外，联合健康手握大量的客户资源，代表了强大的医疗资源购买力，因此在与医疗服务提供商的谈判中拥有更多筹码，也能够获得更多的医疗资源的支持，因此综合以上因素，2020年联合健康的医疗资源网络包括了140万名医生和医疗保健相关人士，较2010年的73万接近翻倍，而触达的医疗机构高达6500家，较2010年的5300家也有明显提升。

图25：公司医疗网络覆盖的医院及其他机构



数据来源：公司年度报告，广发证券发展研究中心

图26：公司医疗网络覆盖的医生及其他医疗人员



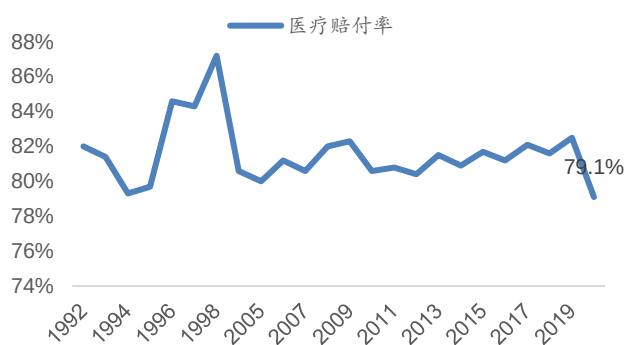
数据来源：公司年度报告，广发证券发展研究中心

2. 协同作用推动公司医疗成本低于同业

健康险行业的长期积淀和健康管理服务业务的协同作用，公司的医疗赔付率逐步走低，且远低于同业。2020年公司医疗赔付率为79.1%，较2019年下降3.4个百分点，且远低于同业的哈门那（83.1%）、安森保险（84.6%）和信诺保险

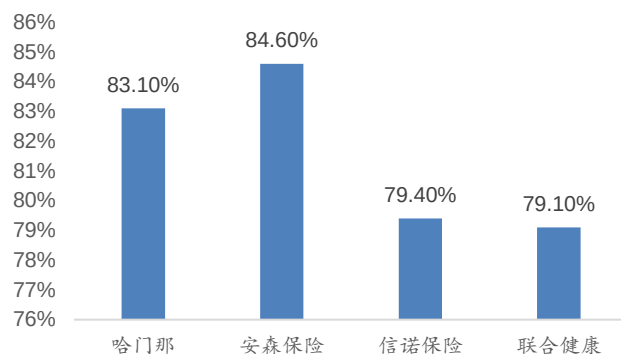
（79.4%），并且在新冠疫情导致护理和检测成本的提升背景下，但公司的医疗赔付率仍旧同比降低主要是健康保险行业税收返还导致。但公司整体医疗费用率处于较低水平，公司的核心优势包括：一方面长期的健康险积淀，庞大的客户渗透率有望在和医疗服务提供商合作时有更多的议价权；二是公司健康管理服务业务协同降低赔付率，包括搭建数字化健康服务平台，提供全方位的健康服务降低赔付率，并且通过药品管理服务，进一步降低用药成本等。

图27：联合健康医疗赔付率逐渐走低



数据来源：公司年度报告，广发证券发展研究中心

图28：2020年同业医疗赔付率的比较



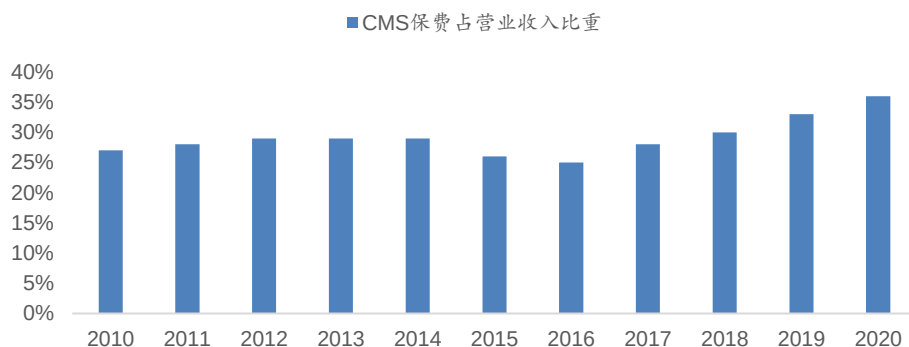
数据来源：公司年度报告，广发证券发展研究中心

3.强大的地方资源，拥有稳定的客源

公司凭借创始人Ellwood通过管理HMO时在医疗保险界积累的影响力，叠加公司多年的健康险运营成效，和州政府或者行业协会达成协议，获取稳定的客户来源。如1998年和AARP签署合作协议，为老年人提供医疗保险和健康管理业务，成为官方合作伙伴也进一步加强公司和地方政府的关系，另外参与州政府所管理的Medicaid业务，提高低收入群体的护理和健康状态。

截至2020年，公司来自于CMS（美国医疗保险和医疗救助服务中心）的保费收入占总营业收入的36%，较其中大部分来自于老年人医疗保险和退休业务。

图29：公司营业收入中来自于CMS的保费占比



数据来源：公司年度报告，广发证券发展研究中心

四、健康管理业务：依托健康险业务，发展迅速

（一）健康管理业务总览：贡献集团收入的比重持续提升

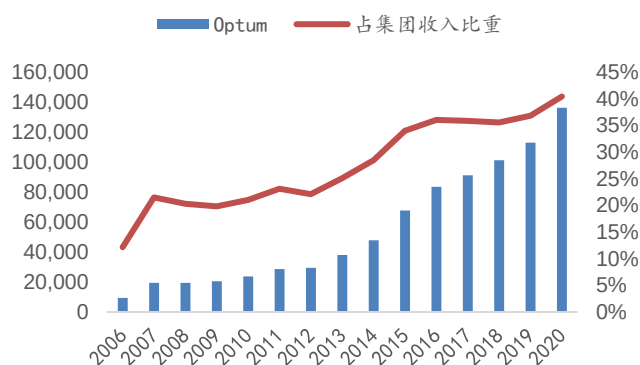
Optum是公司的健康管理与服务业务的子公司，是一家信息和技术支持的卫生服务企业，帮助实现卫生系统现代化并改善整体人口健康，主要分为OptumHealth

(健康管理业务)、OptumInsight (信息技术服务)、OptumRx (药品服务管理) 三个板块为广泛的医疗保健市场提供服务。随着集团健康险业务的发展,出于为客户提供更大范围的服务以及提高健康险服务效率等目的,健康管理业务应运而生。成立初始,公司便已经开始布局健康管理服务,而在1995年公司启用注册商标Optum,2011年将健康管理服务、药品服务管理和信息技术服务进行业务整合,成立了子公司Optum。

OptumHealth为客户提供精细化、全方位的健康管理服务,降低疾病发生概率,提高客户服务体验;OptumInsight为医疗服务参与者提供综合性的服务和解决方案,利用现代化技术帮助客户适应不断变化的健康系统。OptumRx通过自己服务网络为客户提供全方位的药品管理服务,集团通过兼并收购不断扩大自己的议价能力,目前服务网络已拥有超6.7万家零售药店、社区药店、送货服务点等。

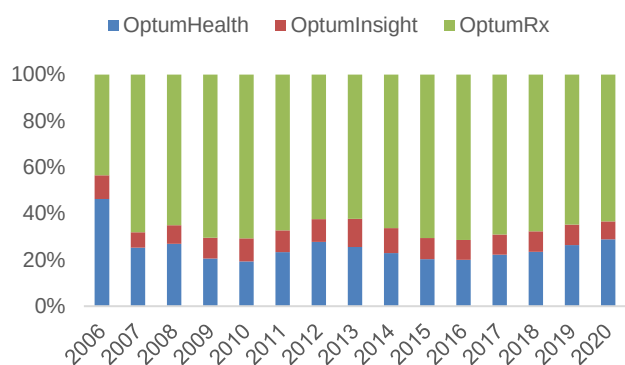
截至2020年,公司健康管理业务创造营业收入1363.1亿美元,2006-2020年复合增速为21.1%,超越健康险业务的增速(8%),因此占集团总收入的比重在持续提升。其中OptumHealth营业收入398亿美元,占比28.8%,较2007年的25.3%略微提升,而OptumInsight和OptumRx分别占比7.8%、63.4%。

图30: 健康管理业务营业收入及占比 (百万美元)



数据来源: 公司年度报告, 广发证券发展研究中心

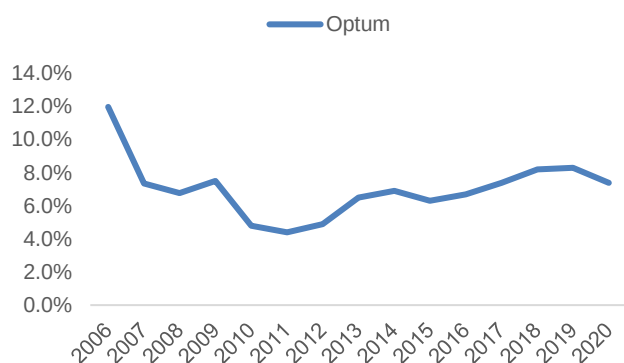
图31: 健康管理业务结构



数据来源: 公司年度报告, 广发证券发展研究中心

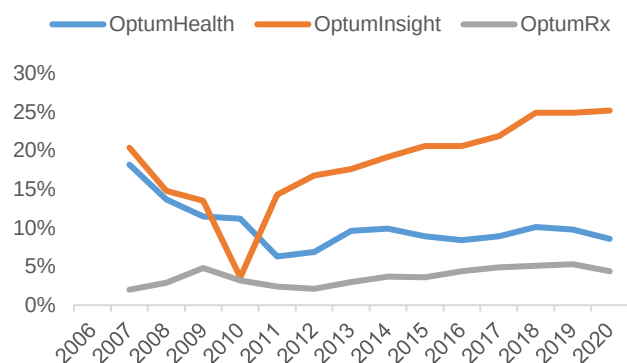
各条线业务的利润率稳步提升,推动健康管理业务的营业利润率整体有所提升。截至2020年,健康管理业务营业利润率为7.4%,较2010年的4.8%有所提升,主要是各业务条线的营业利润率在逐步改善,其中信息技术服务OptumInsight营业利润率较高,2020年为25.2%,较2007年的20.4%有所提升,随着公司前期投入逐渐转化为成果对外输出,信息技术服务的营业利润率在逐步提升;另外健康管理服务OptumHealth营业利润率为8.6%,相较于2006年的18.2%有所下降,2020年下滑的主要原因是新冠疫情导致的服务量增加;药品福利管理OptumRx的营业利润率为4.4%,相对较低。

图32: 健康管理业务营业利润率



数据来源: 公司年度报告, 广发证券发展研究中心

图33: 健康管理板块各业务条线营业利润率



数据来源: 公司年度报告, 广发证券发展研究中心

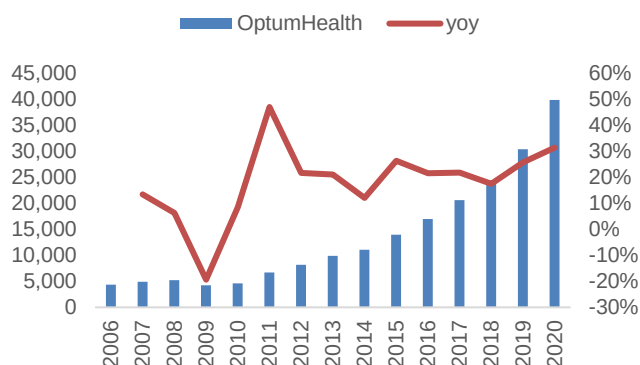
(二) 三大板块分析: 信息技术服务盈利能力最佳

1. OptumHealth

健康管理业务 (OptumHealth) 是为客户提供全方位的健康管理服务, 降低疾病发生概率和赔付费用。公司帮助患者和医疗服务提供商应对复杂的、慢性的健康需求, 提供当地的初级、专科、外科和金及护理, 并提供机型护理规划服务, 且充分利用数字化健康技术, 为消费者和医疗服务提供商提供服务和远程患者监控, 还有创新的医疗保健金融服务。公司直接与消费者、护理服务提供商、雇主、付款人和政府合作, 提高医疗服务质量, 并且同时降低赔付成本。OptumHealth的收入来源包括消费者的健康管理服务收入和金融服务时收取管理费用和管理基金专区的投资收入。

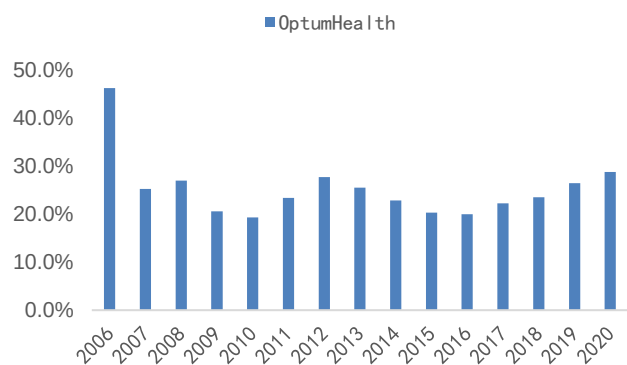
为了给予消费者更好的医疗健康服务, 公司与健康管理服务的提供商由过去按服务付费模式转变到基于服务结果的交付和支付模式, 更好的改善患者的健康。截至2020年, Optum Care拥有超过53000名的医生和1450个社区诊所, 为9800万客户提供健康管理服务, 较2019年的9600万提升200万客户。

图34: OptumHealth营业收入规模及增速 (百万美元)



数据来源: 公司年度报告, 广发证券发展研究中心

图35: OptumHealth 占 Optum 营业收入比重



数据来源: 公司年度报告, 广发证券发展研究中心

2.OptumInsight

信息技术服务（OptumInsight）凭借其领先的分析能力、技术和医疗保健的专业知识，为医院、医生、健康计划、政府和生命科学公司提供数据、分析、研究、咨询、技术和管理服务解决方案，帮助客户降低管理成本、提高临床表现和改造业务。1998年，公司对于集团的信息技术的相关业务和能力，成立Ingenix，是OptumInsight的前身，2010-2011年，先后收购Picis和Axolotl和Executive Health Resources，不断的扩大公司的信息技术能力，2011年成立OptumInsight。

对外看，公司一般与客户签订相对较长的合同，可以保持收入的稳定性，目前服务于美国90%的医院和超过10万名医生。对内看，而信息技术服务也是联合健康其他业务不断发展的重要基石，通过信息技术分析公司庞大的健康保险及医疗服务信息，加强对健康保险的定价、医疗服务的精细化管理，为客户获取优异的医疗资源和降低公司的医疗赔付成本，实现双赢。

表6: OptumInsight客户的主要服务内容

客户	服务内容
卫生系统	为医院、医生和其他护理提供者提供服务，提高其收入，通过技术和服务降低管理成本
健康计划	通过技术，提高支付的真实性，改善健康计划提供服务
州政府	提供先进的技术和分析服务，帮助 Medicaid 等计划的管理现代化，同时提高成本的可预测性
生命科学公司	提供数据、专业分析只是和全面的技术，帮助其采用更全面的方法来推进治疗发现和改善临床结果

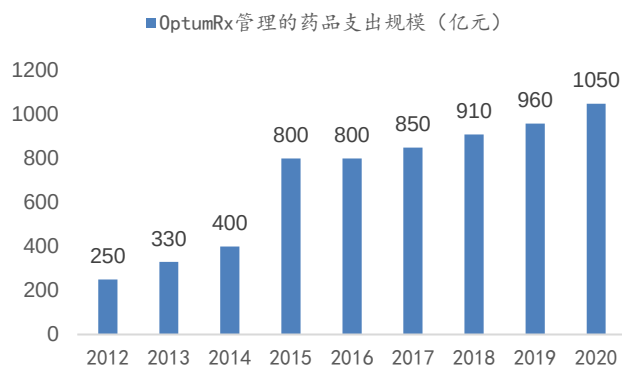
数据来源：公司年度报告，广发证券发展研究中心

3.OptumRx

OptumRx是公司的药品福利计划PBM的平台，提供全方位的药房护理服务，使药品更加实惠，提高PBM发起人和成员的医疗保险和处方药的可负担性。OptumRx提供药物管理、用量管理、质量保证等服务，全面整合人口统计、医学、实验室、药物和其他临床数据，应用分析来推动临床护理洞察力，提高临床质量和成本趋势，使客户和个人消费者受益。

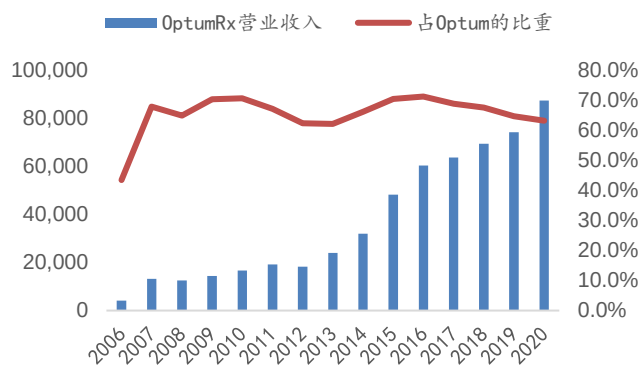
OptumRx的客户包括健康福利提供者、大型国家雇主计划、工会和信托、采购联盟和政府实体，主要靠健康保险经纪人、其他医疗保健顾问和直销进行销售。2020年OptumRx覆盖67000家药店，管理着1050亿美元的药品支出，包括460亿美元的特效药品支出。2020年实现营业收入875亿美元，2006-2020年复合增速为24.5%。

图36: 公司管理的药品支出规模在持续增长



数据来源: 公司年度报告, 广发证券发展研究中心

图 37: OptumRx 的营业收入和占比 (百万美元)



数据来源: 公司年度报告, 广发证券发展研究中心

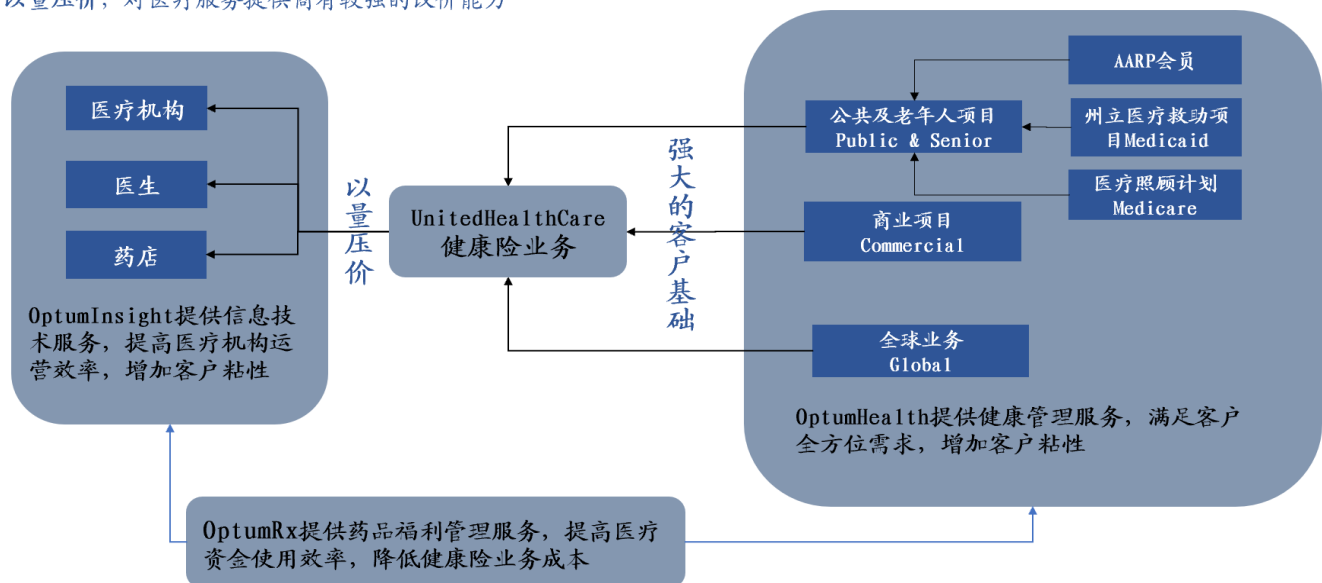
(三) 协同: 健康险提供客户来源, 健康管理赋能

联合健康积累了丰富的健康险业务发展经验, 拥有强大的医疗服务关系网络, 为健康管理业务的发展提供客户基础。健康管理服务为健康险业务提供费控工具, 有助于优化健康险业务赔付流程, 通过挖掘用户数据为用户提供健康管理服务, 丰富健康险业务服务, 深度捆绑健康险客户。

联合健康通过与政府合作, 拥有稳定的客户来源, 通过医疗管理服务优化健康险业务并且能更好地绑定医疗服务提供商和消费者。健康险企业的服务网络具有规模优势, 联合健康服务网络的扩大吸引更多的医疗服务提供商, 并且能够消费者提供更低价优质种类丰富的服务, 进一步吸引消费者。

图38：健康险业务和健康管理服务相互促进、互为补充

- 健康险客户数量大，对医疗服务提供者有较大吸引力，促进服务网络的壮大；
- 以量压价，对医疗服务提供商有较强的议价能力
- 健康险渠道能力强：与公共机构合作，客户来源稳定、群体广泛；
- 医疗服务网络强大，提供多样服务满足客户需求，吸引力强。



数据来源：公司年度报告，广发证券发展研究中心

五、投资建议：国情差异，难打造中国版“联合健康”

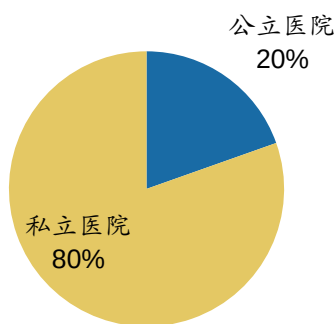
从医疗体系、医疗保险制度、医疗费用支出结构等三个方面去观察，美国和中国存在较大的差异。在美国，面临高额的医疗费用、医生为主的私立医院结构等，居民的痛点在于“看病贵”的问题，而在中国，公立医院为主的医疗体系、医疗资源分布的不均衡、社会保险为主的医疗保险制度下，居民的痛点不仅在于“看病贵”，还在于“看病难”的问题。

（一）医疗制度的显著差异

首先，从医疗体系来看，中国以公立医院为主，美国以私立医院为主。2019年，美国私立医院4804家，而公立医院仅1170家（数据来源于美国AHA），私立医院占据美国医院的80%比重，而中国医疗机构以公立医院为主，2019年公立医院占比74%，且优质的医生主要集中于公立三甲医院，因此在中国商业保险机构难以与医生建立合作网，并且医生在诊疗、药品的开具等行为上占据主导地位。且国内医疗资源相对并不均衡，公立医院的诊疗负担已经较重，如2021年5月份三级医院病床使用率为85.3%，较整体医院的使用率75.2%高出10个百分点。

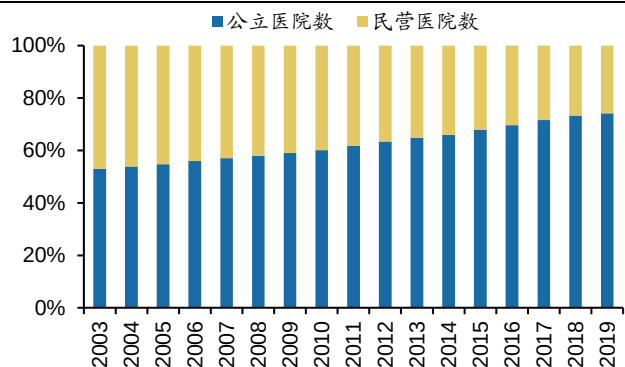
并且从医院和药房的关系来看，美国是医院和药房分离的，医院主要的职能是提供手术、康复护理等，而绝大部分的处方药需要去药房购买，因此商业保险公司通过掌握客户的医疗就诊信息，对其处方药购买的行为可以进行一定的影响，而掌握了客户的就诊信息的商业保险公司对于药房的主动权较高，为药品福利计划PBM提供一定的制度基础。而反观我国，医院均设有药房，处方药和部分药品仅供于医院的药房，而院外的药房主要提供非处方药。

图39: 美国以私立医院为主 (截至2019年末)



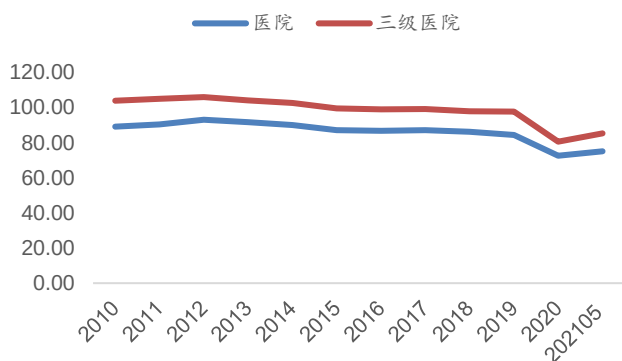
数据来源: AHA, 广发证券发展研究中心

图 40: 中国以公立医院为主



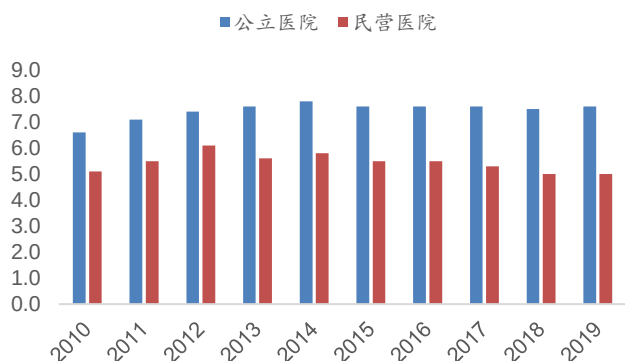
数据来源: wind, 广发证券发展研究中心

图41: 三级医院的病床使用率高于医院整体水平 (%)



数据来源: wind, 广发证券发展研究中心

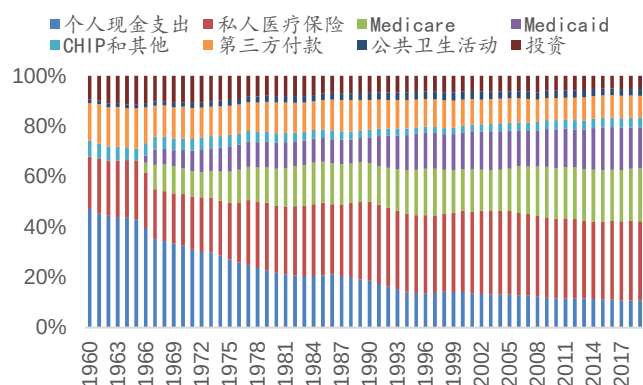
图 42: 公立医院和民营医院医师日均诊疗人次 (人)



数据来源: wind, 广发证券发展研究中心

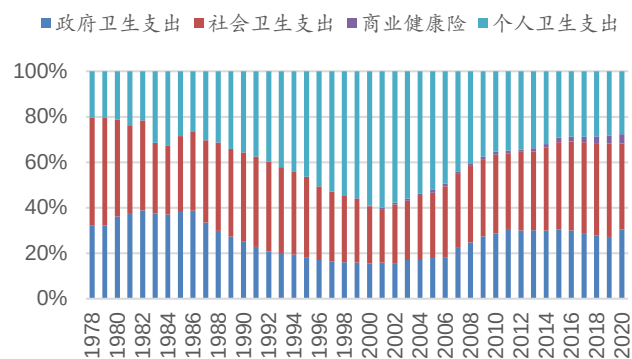
其次, 从医疗保险制度来看, 美国以商业保险为主, 而中国以社会保险为主。美国医疗保险分为社会医疗保险和商业医疗保险, 社会医疗保险主要覆盖老年人和低收入群体, 2020年美国社会医疗保险和商业医疗保险分别覆盖34.8%、66.5%的人群, 另外美国商业医疗保险以团险为主, 即雇主购买的商业医疗保险; 而国内医疗保险以社会保险为主, 商业医疗保险覆盖率较低, 2020年基本医疗保险覆盖全国95%以上的人口, 并且商业医疗保险以个人保险为主, 团体险占比较低。因医疗保险制度的差异, 美国卫生费用的支出结构中, 商业医疗保险贡献31%的医疗费用, 而Medicare和Medicaid分别仅占比21%、10%, 因此商业医疗保险作为最大的医疗支付方, 在医疗体系中占据有利的话语权, 可以统筹医疗资源的需求方和提供方。而中国, 2020年政府卫生支出、社会卫生支出、商业保险支出、个人支出分别占比为30.4%、37.9%、4%、27.7%, 商业保险在卫生费用占比较小, 基本医疗保险直接与医院结算, 商业健康险公司对医疗服务提供者的议价能力弱, 难发挥管理式医疗的优势, 难通过捆绑医疗服务提供商及消费者等各利益方来提高医疗资金使用效率。

图43: 美国医疗费用来源结构



数据来源: CMS, 广发证券发展研究中心

图 44: 我国医疗费用来源结构



数据来源: wind, 广发证券发展研究中心

（二）借鉴之处：差异化竞争，解决居民医疗痛点

在美国和中国医疗体系和保险制度的差异背景下，完全照搬美国联合健康的经验实属不可取，但也并非全无借鉴之处，可借鉴联合健康在打造保险+服务、保险+信息技术等方面的协同作用，增加保险产品的吸引力，在民生痛点的“看病难”和“看病贵”方面去发力。

1. 保险产品+医疗服务

联合健康医疗保险覆盖美国13.1%的人口，不仅是凭借政府的关系，更多是公司在医疗健康管理服务方面给客户更多的医疗资源，并且通过绩效模式增强医疗服务提供商的质量，为客户提供优质的医疗资源。而在我国目前健康险更多是解决“看病贵”的痛点，造成同质化严重的行业发展瓶颈，因此陷入各大保险公司在病种数量、保费价格方面的恶性竞争，且在健康险杠杆倍数较低的背景下，产品的吸引力日渐低下。借鉴联合健康的经验，保险公司目前正在积极的布局大健康产业链，为客户提供增值服务，如平安的“好医生”、太保的“太保蓝本”、友邦的“愈从容”等，均是在产品之余提供医疗健康的服务，差异化的竞争有望增加产品的吸引力，而不仅仅是价格的竞争。平安通过竞价获取北大方正集团的控制权，其中包含北大国际医学院，而太保公布《2020-2025年的大健康发展规划》，着力打造国内领先的健康保障综合服务提供商。

2. 强化信息技术的应用

注重信息化管理系统的搭建，合理利用强大的数据平台，提升公司的产品设计能力、健康服务能力，同时减少公司医疗费用支出。健康险公司为提高服务水平、增加客户粘性，应注重建设信息化管理平台，合理合法收集利用会员的健康数据，通过对会员病历、药物处方、检查报告等数据进行收集与分析，更好地提供健康管理、疾病预测等健康保障服务，从整体上减少会员的医疗费用，在降低保费的同时，达到帮助客户更好地进行健康管理、节约成本的目的。

（三）投资建议

考虑到信息技术的布局、健康生态的布局对保险业务竞争力的加强等因素，推荐中国平安（A/H），考虑到健康管理服务的布局，养老社区等差异化竞争的优势，推荐中国太保（A/H）和友邦保险（H）。

六、风险提示

健康管理服务不达标导致产品竞争力下滑；随着宏观经济的下行，长端利率的下降超预期；另外房地产行业的风险持续蔓延，导致保险公司的资产端出现风险；再是监管对于销售的趋严，导致代理人下滑，新单销售继续低于市场预期。

广发非银金融行业研究小组

- 陈 福：首席分析师，经济学硕士，2017年3月进入广发证券研究发展中心。
- 陈 卉：资深分析师，英国布里斯托大学（University of Bristol）金融投资专业硕士，2017年进入广发证券发展研究中心。
- 陈 韵 杨：资深分析师，香港中文大学经济学硕士，中山大学学士，2017年进入广发证券发展研究中心。
- 刘 淇：资深分析师，中南财经政法大学投资学硕士，2020年进入广发证券发展研究中心。
- 陈 思 宇：研究助理，西安交通大学硕士，2020年进入广发证券发展研究中心。

广发证券—行业投资评级说明

- 买入：预期未来12个月内，股价表现强于大盘10%以上。
- 持有：预期未来12个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%~+10%。
- 卖出：预期未来12个月内，股价表现弱于大盘10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

- 买入：预期未来12个月内，股价表现强于大盘15%以上。
- 增持：预期未来12个月内，股价表现强于大盘5%-15%。
- 持有：预期未来12个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%~+5%。
- 卖出：预期未来12个月内，股价表现弱于大盘5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市	香港
地址	广州市天河区马场路 26号广发证券大厦 35楼	深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 31层	北京市西城区月坛北 街2号月坛大厦18 层	上海市浦东新区南泉 北路429号泰康保险 大厦37楼	香港德辅道中189号 李宝椿大厦29及30 楼
邮政编码	510627	518026	100045	200120	-
客服邮箱	gfhqyf@gf.com.cn				

法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。

广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。

广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。

本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或者口头承诺均为无效。

本报告署名研究人员、联系人（以下均简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究人员的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。

研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经

营业收入部分来源于广发证券的投资银行类业务。

本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。

本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

本研究报告可能包括和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息（“信息”）。请注意此信息仅供用作组成我们的研究方法/分析中的部分论点/依据/证据，以支持我们对所述相关行业/公司的观点的结论。在任何情况下，它并不（明示或暗示）与香港证监会第5类受规管活动（就期货合约提供意见）有关联或构成此活动。

权益披露

(1) 广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去12个月内并没有任何投资银行业务的关系。

版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。